

팀 회의 안건 — 결선 Q&A 구멍 메우기

2026-08-04 · 예상 30분 · 조사 없이 “정하기만 하면” 닫히는 것들만 모았습니다

왜 이 회의가 필요한가

결선 Q&A는 8분입니다. 우리가 지금 답할 수 있는 것과 없는 것을 점검해보니, **알고리즘·판정 로직 질문은 아주 촘촘하게 준비돼 있는 데, 아래 질문들에는 답할 근거가 아예 없습니다.**

- “케어가 열리면 78세 고객의 자녀에게도 알리나요? 누구 동의로?”
- “고객이 케어를 거부하면 보험료는 어떻게 되나요?”
- “3월에 케어로 표시했는데 5월에 사망사고가 났습니다. 감지하고도 왜 안 막았나요?”
- “케어 검토하는 사람은 누구고, 1건에 얼마가 듭니까?”
- “파일럿의 성공 기준이 뭐니까?”

이건 자료를 더 찾아야 하는 문제가 아니라 **우리가 아직 안 정한 것들**입니다. 그래서 오늘 정하면 바로 닫힙니다.

아래 5개 안건, 각각 **선택지**와 **권고안**을 붙였습니다. 골라주시기만 하면 답변서·장표에 반영하겠습니다.

안건 1. 케어가 열렸을 때 누구에게 알리나 (10분)

상황 — 우리 설계에 “사람이 검토한다”는 말은 있는데, 그 결과를 **누구에게 전달하는지**가 정해진 적이 없습니다. 심사위원이 가장 찌르기 쉬운 지점입니다. 고려자 대상 상품에서 “가족에게 알린다”는 순간 개인정보와 자율성 문제가 동시에 터지고, “본인에게만”이라고 하면 “그럼 예방 효과가 뭐냐”는 반문이 옵니다.

선택지

	통보 대상	장점	위험
A	본인에게만	개인정보 안전, 자율성 존중	“가족 안심” 서사가 약해짐
B	본인 + 사전 지정 가족	예방 효과 큼	동의 설계 복잡, 낙인 논란
C	본인 우선 + 본인이 동의한 경우 에만 가족	둘 다 확보	설명이 한 줄 길어짐

권고: C — “케어 안내는 본인에게 갑니다. 가입 시 또는 케어 발생 시 본인이 원하면 지정한 가족에게도 갈 수 있고, 그 선택은 언제든지 바꿀 수 있습니다.”

본인 동의가 앞에 있으면 개인정보·자율성 질문이 동시에 닫히고, “가족의 안심”이라는 우리 기존 서사도 살아남습니다.

같이 정할 것 — 감독당국·의사·경찰이 요구하면? → 권고: **법적 의무가 없으면 제공하지 않는다.** (우리는 진단 기관이 아님)

안전 2. 고객이 케어를 거부하면 (5분)

상황 — 케어는 “권유”라고 말해왔는데, 거부했을 때 13%p 할인 축소가 그대로면 사실상 권유가 아니라 벌칙입니다. 심사위원이 이것 짚으면 우리 서사 전체가 흔들립니다.

선택지

	거부 시 요율	논리
A	그대로 축소 유지	요율은 위험 지표에 따른 것, 검토 수용과 무관
B	축소하지 않음 (검토 수용 시에만 적용)	진짜 “권유”가 됨
C	축소하되 거부 사유를 기록·재검토	절충

권고: A + 표현 교정 — 요율은 검토 수용 여부가 아니라 **관측된 지표**에 따라 정해지는 게 맞습니다(수용을 조건으로 걸면 오히려 “돈으로 압박”이 됩니다). 대신 **“권유”라는 표현을 고쳐야 합니다.**

정확한 표현: “요율은 관측 지표로 정해지고, 케어 지원은 그와 별개로 제안됩니다. 지원을 받지 않아도 요율이 더 나빠지지 않고, 받는다고 좋아지지도 않습니다.”

이러면 “케어 = 압박”이라는 프레임이 깨집니다.

안전 3. 케어 검토, 실제로 누가 얼마나 (5분)

상황 — “사람이 검토한다”가 우리 최강 방어막인데, 그 사람이 누구인지 한 번도 말한 적이 없습니다. “몇 명 필요하고 1건에 얼마 드나”라고 물으면 지금은 침묵입니다.

참고 실측 — 우리 시물에서 케어는 180건 중 30건(16.7%), 전원 1개월 발동입니다. 계약 1만 건이면 연 1,600건 남짓, 하루 5~7건 수준입니다.

정할 것 세 가지

- 검토 주체: 보험사 담당자 / 우리 / 외주 → 권고: **보험사 담당자**(우리는 근거를 제공하는 쪽)
- 1건 소요: 권고 **20~30분**(리포트 확인 + 통화)
- 케어 발생 후 흐름: 권고 — 발동 → 담당자 검토(3영업일 내) → 본인 안내(문자·통화) → 원하면 지원 연결

숫자가 정확할 필요는 없습니다. “계산해본 적 있다”는 것 자체가 답변이 됩니다.

안전 4. 사고가 났을 때 우리 책임은 (5분)

상황 — “케어로 표시했는데 사고가 났다, 알고도 왜 안 막았나”는 실제로 나올 수 있는 질문이고, 잘못 답하면 법적 리스크까지 갑니다.

권고 스탠스 (그대로 읽으면 되는 문장)

“저희는 진단하지 않고 예측하지 않습니다. 운전 데이터에서 평소와 달라진 점을 관찰해 사람이 확인할 근거를 만들 뿐입니다. 의학적 판단이나 운전 적합성 판정은 저희 역할이 아니며, 운전 여부의 결정권은 고객에게 있습니다. 케어는 개입 의무를 만들지 않고 지원 기회를 만듭니다.”

같이 확인할 것 — 이 문장을 그대로 쓸지, 법무 검토 후 확정할지. 권고: 결선에서는 이 수위로 답하고, 파일럿 전 법무 검토를 로드맵에 명시.

안건 5. 파일럿 성공 기준 하나만 정하기 (5분)

상황 — 파일럿 얘기는 계속 나오는데 “무엇이 되면 성공인가”가 정해진 적이 없습니다. “성공 기준이 뭐냐”는 질문에 답이 없으면 로드맵 전체가 공허해집니다.

선택지 (1차 기준 하나만)

	성공 기준	장점	단점
A	케어군과 우대군의 실제 사고율 차이	우리 주장의 핵심 검증	표본·기간 필요
B	케어 판정의 오탐률(검토자가 기각한 비율)	6개월이면 측정 가능	손해율과 직결 안 됨
C	우대군 손해율 vs 대조군	보험사가 원하는 지표	1년 이상 필요

권고: B를 1차, A를 2차 — 파일럿 기간이 짧으면 사고율은 안 나옵니다. “6개월 안에 케어 오탐률 0% 이하”를 1차 종결점으로 두고, 사고율·손해율은 2차로 미루는 게 정직하고 실행 가능합니다.

정할 숫자 하나 — 오탐률 몇 % 이하를 성공으로 볼지 (권고: 30% 이하 = 검토 10건 중 7건은 실제로 확인이 필요했던 케이스)

부록. 회의 중 5분이면 되는 확인 2건

(1) 요약 문장 수정 승인

현재 마스터 문서 요약에 이렇게 쓰여 있습니다:

“보험료 불이익 대신 예방형 케어를 연결”

실제 설계와 어긋납니다. 케어가 열리면 보너스가 정지되고 할인이 13%p 줄어 고객이 내는 돈은 늘어납니다(동시변화형 실측: 평균 할인 19.6% → 7.9%). 정확한 문장으로 교체 필요:

“할증 없이 예방형 케어를 연결 — 최악의 경우에도 기존 마일리지 할인선이 하한이며, 할인 축소는 사람 검토를 거칩니다.”

(2) 문헌 등급 규약 하나

초록만 확인한 논문(원문페이월 등)을 인용 가능으로 볼지 정해야 합니다. 지금 같은 논문이 문서마다 다른 등급으로 적혀 있습니다.

권고: “초록 확인 = 인용 가능, 단 ’초록 기준’임을 명시” → 이 한 줄로 5건이 한 번에 정리됩니다.

오늘 정하면 닫히는 것

안건	답할 수 있게 되는 질문
1	통보 대상 · 가족 고지 · 개인정보 · 낙인
2	케어 거부권 · “권유인가 별칙인가” · 자율성
3	운영 인력 · 비용 · 고객 접점 · 실행 가능성
4	사고 책임 · 법적 지위 · 진단 여부
5	파일럿 성공 기준 · 검증 계획의 구체성

남는 것 (조사 필요, 오늘 안건 아님) — 시장 규모, 경쟁사 비교, 해외 규제(싱가포르·EU), 손해율 개선의 정량 근거. 이걸 별도로 시간을 잡아야 합니다.